

Informe clínico resumido — canina “Chiqui”

Período analizado: 20/3/2026 – 13/9/2026 · **Fuente:** 40 planillas caseras diarias (glucemia, insulina, fármacos, comida) + 15 informes de laboratorio (1/2024 – 8/2026).

Referencia: github.com/mcphisto-netizen/registros-chiqui · Panel interactivo: [panel-chiqui.html](#) · Documento generado 13/9/2026.

1 · Diagnósticos y contexto

Diagnósticos	Diabetes mellitus insulín dependiente (posición 20/3/2026) · Hiperadrenocorticism (Cushing) · Hipotiroidismo · Hepatopatía mixta (lipidosis difusa moderada + colangiohepatitis linfoplasmocítica, biopsia 26/5/2026) · Colectomía por mucocèle biliar (24-26/4/2026) · Gastroenteritis aguda 17-23/8/2026
Esquema actual (7-13/9)	Ayuno: T4 ¼ + Dipirona ¼. Mediodía y noche: Trilostano ½, Silimarina ¼, Fenofibrato ¼, Caninsulin 0,18-0,2 U (ajuste por lectura; omitida 12/9 mediodía por peso). Desde 12/9: Biletan enzimático ½ + Psyllium. Dieta antiinflamatoria desde 10/9: cerdo 125 g + manzana 20 g + boniato 25 g + sopa de moro (3 cucharadas).

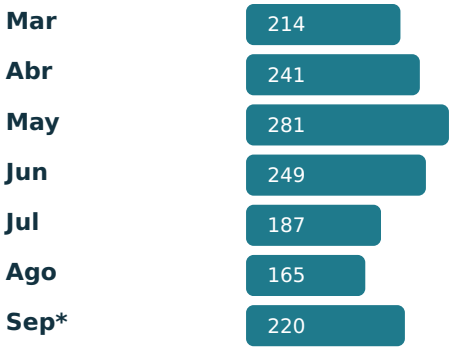
2 · Glucemia de las planillas

Valores domiciliarios; ante mediciones múltiples del mismo momento se registra la más baja (criterio acordado con el responsable, dos medidores: Maverick y Accucheck, con diferencia sistemática de ~16-20 mg/dL).

Mes	n	Media	Mín	Máx	n	Media	Mín	Máx
MEDIODÍA	(franja azul)			MEDIANOCHE	(franja violeta)			
Marzo (22-31)	11	214	164	267	12	236	129	441
Abril	27	241	140	514	28	262	150	495
Mayo	30	281	120	498	31	331	192	548
Junio	30	249	129	357	30	285	166	370
Julio	31	187	55	428	32	259	50	433
Agosto	31	165	40	260	31	225	62	341
Sept (1-13)	13	220	80	305	12	287	163	368

Media general del período: mediodía ~214 · medianoche ~264. Hipoglucemias <70 registradas: 7 (18/7, 19/7 ×2, 24/7, 13/8, 21/8, 24/8), mínima 40 (24/8) — corregidas con miel/pollo; curva documentada 8-10/8 (52 → 41 → rescate → rebote 341). Eventos: cirugía 24-26/4 y postoperatorio 27/4-10/5 (pico), gastroenteritis 17-23/8.

Mediodía · media mensual (mg/dL)



Medianoche · media mensual (mg/dL)



3 · Laboratorio relevante

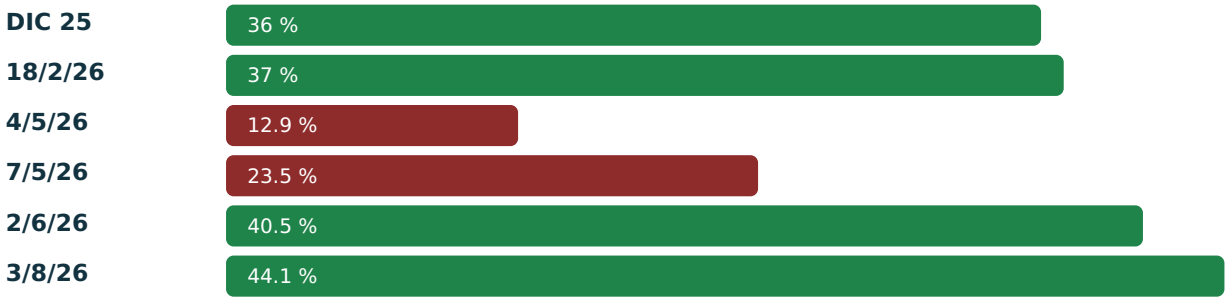
Fecha	Hallazgo	Lectura
18-20/2/26	Glucosa 487-508 · FAL 1626 · UCCR 4620/40,39 (alta) · T4 libre 0,17 + TSH 0,65 · plaquetas 934000	Debut triple: diabetes + Cushing + hipotiroidismo + colestasis marcada
4/5/26	Hto 12,9 · Hb 4,9 · ALT 160 · FAL 386 · glucosa 212 · amilasa 1163 · calcio 11,3 (corr 12,2)	Anemia severa postquirúrgica; laboratorio hepático ya en descenso
7/5/26	Hto 23,5 · leucocitos 14400 · reticulocitos 5%	Recuperación con respuesta regenerativa
26/5/26	Biopsia: lipidosis difusa moderada + colangiohepatitis linfoplasmocítica	Hepatopatía mixta
2/6/26	ALT 149 · FAL 136 · triglicéridos 819 · colesterol 309 · UPC 1,7 · cetonuria · suero lipémico	Mejoría hepática; proteinuria + hiperlipidemia franca
3/8/26	UCCR 22,8 (normal) · ALT 344 · FAL 283 · UPC 0,05 (normal) · T4 libre 0,70 (baja) · urea 95 · TG 277 · colesterol 281 · glucosuria 232	Cushing controlado; rebrote hepático; tiroides aún baja; riñón recuperado

LAB04 y LAB05 provienen de laboratorio humano: valores orientativos, rangos de referencia no aplicables. LAB02 = LAB03 (mismo protocolo del 3/8, completo en LAB03). Bilirrubina siempre normal; ácidos biliares 43 (LAB14). Densidad orina conservada (1010-1035).

Hígado — FAL (UI/l):



Hematocrito en evolución:



ALT (UI/l): feb 533 → 4/5 160 → 2/6 149 → 3/8 344. Urea 95 con creatinina normal (3/8) y urea 77,5 (4/5): control renal recomendable.

4 · Observaciones derivadas de los datos

- **El debut respondió rápido:** glucosa ~500 (feb) → ~214–236 en planillas (finales de marzo), -50% con insulina + Trilostano + T4.
- **Mayo = postoperatorio + anemia, no falla del esquema.** Hto 12,9 (4/5) y pico de hiperglucemias 400–548. Sin corticoides (por Cushing): estrés quirúrgico + inflamación + anemia. La serie roja se recuperó sola: 12,9 → 23,5 → 40,5 → 44,1 (ago).
- **Hígado independiente de la glucosa.** Mejoró tras cirugía (FAL 1626→136) pero **rebotó en agosto (ALT 344, FAL 283)**, cuando la glucemia promediaba su mejor valor (165). La biopsia nombra la causa (lipidosis + colangiohepatitis).
- **Cushing controlado:** UCCR de 4620/40,39 (feb) → 22,8 (ago, <40) bajo Trilostano ½ sostenido.
- **Tiroides posiblemente infratratada:** T4 libre 0,17 → 0,70, aún bajo rango (0,8–2,5) con ¼; aumento a ½ en agosto. Requiere control T4/TSH para confirmar dosis.
- **Riñón recuperado:** proteinuria jun (UPC 1,7) → ago (UPC 0,05). Creatinina siempre normal.
- **Lípidos rebeldes:** triglicéridos 819 → 277; colesterol clavado ~281–310 todo el año (fenofibrato justificado).
- **Brecha noche/mes continúa** (+20 a +70 sobre el mediodía): presenta picos nocturnos a pesar del descenso del promedio (dosis diseñada para franja diurna).
- **Glucosuria persiste (357 → 232)** coherente con la brecha nocturna.
- **Trombocitopenia dic-2025 (56.000) y amilasa 1652 sin diagnóstico** (atención veterinaria deficiente en ese período; sin evidencia de pancreatitis posterior a la fecha: ver roadmap).

5 · Roadmap sugerido

A · Estudios en el próximo control

#	Estudio	Justificación	Prioridad
1	Fructosamina	Sin ninguna en 2 años. Arbitra entre medidores/estrés de consulta, valida promedios y define ajuste de insulina. Interpretable hoy (albúmina 3,39). Bien para ello.	Alta
2	Lipasa pancreática específica canina (cPLI)	Amilasa 1652 (12/25) y 1163 (4/5/26) con antecedente de trombocitopenia: descarta/enfoca pancreatitis.	Alta
3	T4 libre + TSH	Validar si la dosis de ½ alcanza (T4l 0,70 con ¼).	Media
4	Bioquímica hepática + ácidos biliares	Control post-colecistectomía y post-Biletan/Psyllium (rebrote ago).	Media

5	UCCR de seguimiento	Consolidar control de Cushing.	Media
6	Rasme renal: urea/ creatinina/albúmina	Urea 95 con creat normal (3/8); urea 77,5 (4/5).	Baja

B · Ajustes terapéuticos y de manejo

- **Apuntar a la brecha nocturna:** considerar fraccionar/redistribuir insulina (o evaluar con fructosamina/curva si el pico vespertino es real) — la secuencia actual deja la noche cubierta por encima del objetivo.
- **Manejo de hipos:** 7 episodios <70 desde julio. Mantener protocolo de rescate (miel + pollo, como en 8–10/8) y revisar si el ½ de Trilostano en horarios del día coincide con caídas.
- **Seguimiento hepático:** repetir ALT/FAL ~1–2 meses tras inicio de Biletan/Psyllium (12/9/26) para evaluar respuesta al rebrote de agosto.
- **Dieta antiinflamatoria (10/9):** evaluar tolerancia y efecto sobre glucemia tras 4–6 semanas; documentar si mantiene el repunte de septiembre (> agosto).
- **Si cPLI positiva:** dieta baja en grasas y ajuste de fenofibrato/asesoría; si negativa, se descarta el foco pancreático y se refuerza el manejo metabólico.

Preguntas abiertas para el próximo control

- Fructosamina y cPLI: *nunca* realizadas.
- Etiología de la trombocitopenia de dic-2025 y de las plaquetas 934000 de feb-2026 (estrés/reactivo vs enfermedad primaria de médula).
- Posible sangrado gastrointestinal en dic-2025 o perioperatorio (no documentado).
- Correlación entre laboratorio (212, 4/5/26) y planillas caseras (400+) de la misma semana: suscita validación de medidores.

Documento generado automáticamente a partir de los registros digitalizados. Los valores domiciliarios son auto reportados por el responsable; los datos de laboratorio provienen de 15 informes originales (LAB01–LAB15) incluidos en el repositorio.